โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก

ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ผู้เรียบเรียง

เด็กๆ อาจเคยพบเห็นผู้พิการที่น่าสงสารเดินไม่ได้ มือหยิบจับสิ่งของไม่ได้ หรือต้องเจ็บปวดทุกครั้งที่ขยับแขนขา บางคนอาจพิการมาตั้งแต่เกิด บางคนอาจพิการจากอุบัติเหตุ หรือพิการจากการเป็นโรคต่างๆ ดังเช่นโรคข้ออักเสบซึ่งเกิดขึ้นเรื้อรังเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

ข้อนิ้ว ข้อมือ ข้อเท้า ข้อศอก หรือข้อเข่าของคนที่เป็นโรคนี้อาจบวมแดง บิดหงิกงอ ทำให้เจ็บปวด เคลื่อนไหวลำบาก ขยับไม่ค่อยได้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ ไม่ไปให้คุณหมอรักษา แขนขาอาจใช้งานไม่ได้ กลายเป็นคนพิการตลอดไป และมีชีวิตอยู่อย่างลำบากมาก

การยกสิ่งของด้วยมือทั้ง ๒ ข้าง และน้ำหนักไม่มากจนเกินไป ช่วยให้ข้อมีระยะเวลาการใช้งานยาวนานขึ้น

ถ้าเด็กๆ โตขึ้นแล้วไม่อยากเป็นโรคข้ออักเสบอย่างนี้ เด็กๆ ต้องคอยดูแลสุขภาพของตนเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ พยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน นอกจากนี้ควรใช้งานข้อต่างๆ ของตนเองอย่างทะนุถนอม ต้องระวังไม่ยกของที่หนักเกินไป ถ้าจะยกก็ให้ใช้มือทั้ง ๒ ข้าง ไม่ใช้มือแค่ข้างเดียว หากทำงานที่ต้องใช้ข้อมือก็อย่าทำเป็นเวลานานจนเกินไป หรือเวลาที่ใช้ปากกา ดินสอ เครื่องมือ และเครื่องเขียนต่างๆ ก็ควรให้มีขนาดใหญ่พอที่จะหยิบจับได้สะดวก ไม่เกร็งมือมากเกินไป

เวลาที่ญาติผู้ใหญ่ของเด็กๆ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา บ่นปวดเจ็บตามข้อมือ ข้อนิ้วเริ่มขยับไม่ได้ ควรขอให้ญาติของเด็กๆ ไปพบคุณหมอ เพราะถ้าคุณหมอตรวจพบได้เร็วว่าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ คุณหมอจะได้รักษาท่านได้ทันเวลา ก่อนที่จะเป็นมากหรือเป็นเรื้อรัง จนไม่อาจรักษาให้หายได้

ส่วนเด็กกลาง
ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ผู้เรียบเรียง

สาเหตุและอาการของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นใกล้บริเวณข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด เคลื่อนไหวได้ลำบาก จนกระทั่งไม่อาจเคลื่อนไหวหรือรับน้ำหนัก และอาจถึงกับพิการได้ในที่สุด

อาการข้ออักเสบจากโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับข้อต่างๆ ของร่างกาย แต่พบบ่อยที่บริเวณข้อมือ ข้อนิ้ว ข้อเข่า และข้อเท้า โดยเยื่อบุข้อจะอักเสบและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เยื่อบุข้อหนาขึ้น ขณะเดียวกันมีของเหลวและเลือดมาเลี้ยงที่ข้อเพิ่มขึ้น จนเกิดอาการปวดบวมและข้อขัด รวมไปถึงการหลั่งสารออกมาทำลาย กัดกร่อนกระดูกบริเวณข้อ หรือแม้แต่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆ ข้อ

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีอายุมากกว่า ๑๖ ปีขึ้นไป ถึงแม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นโรคนี้คืออะไร แต่เชื่อกันว่าโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีสาเหตุจากหลายปัจจัยประกอบกัน ตั้งแต่พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค เช่น ถ้ามีบิดามารดาที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ บุตรมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง ๑๐ เท่า และพบโรคนี้ในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายหลายเท่าตัว หรือพบว่าผู้สูบบุหรี่จะมีสารที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการแพ้ภูมิตนเองจนนำไปสู่การเกิดโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ รวมไปถึงเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่พบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของข้อได้

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์จะมีอาการ ระดับของความรุนแรง หรือระยะเวลาของการเกิดโรคที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ส่วนใหญ่แล้วในระยะแรกของการเกิดโรคมักจะมีอาการอักเสบเฉพาะบางข้อเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปหลายสัปดาห์ แต่อาจมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการข้ออักเสบเกิดขึ้นทั้งร่างกาย โดยมีอาการต่อไปเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ และผู้ป่วยส่วนน้อยที่จะมีอาการข้ออักเสบเริ่มต้นแบบเฉียบพลันหรือปวดกล้ามเนื้อรุนแรงคล้ายขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้น

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์นอกจากจะทำให้ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยอักเสบ บวมแดงและฝืดแข็ง ยังอาจรุนแรงจนทำให้โครงสร้างของข้อพิการได้ เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูปหรือไม่สามารถกระดกนิ้วมือได้ ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น ข้อเข่าอ่อนแรงไม่สามารถเหยียดเข่าตรง ข้อสะโพกอักเสบเรื้อรังจนหัวกระดูกสะโพกดันเบ้ากระดูก ข้อกระดูกคอฝืดแข็งเคลื่อนไหวลำบาก หรือปวดร้าวถึงท้ายทอย กระดูกอ่อนตามผิวข้อต่างๆ อาจถูกทำลายหายไปจนเอกซเรย์เห็นเป็นช่องว่างระหว่างข้อ

นอกจากเกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆ รวมถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ตัวร้อน และน้ำหนักตัวลดแล้ว ผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ยังอาจมีอาการอักเสบนอกข้อเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนขนาดเล็กเกิดขึ้นที่ผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดที่ผิวหนังมีอาการอักเสบ ตาแห้งหรือเยื่อตาขาวอักเสบ ข้อต่อกล่องเสียงอักเสบจนทำให้เจ็บคอเวลากลืนอาหาร และเสียงแหบ เจ็บหน้าอกขณะหายใจ

อาการอักเสบของข้อต่อกล่องเสียง ทำให้เจ็บหน้าอก เจ็บคอ เสียงแหบ

ซึ่งเป็นอาการอักเสบนอกข้อของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่พบได้บ่อย

เนื่องจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจมากกว่าปกติ มือทั้งสองข้างมีอาการชาและอ่อนแรงเพราะเส้นประสาทถูกกดทับ เกิดอาการซีดหรือมีภาวะโลหิตจาง ซึ่งถ้าเป็นเรื้อรังจะทำให้ตับและม้ามโต และเม็ดเลือดขาวต่ำได้

การวินิจฉัยและการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ควรได้รับการวินิจฉัยโรคและระดับความรุนแรงของโรคโดยเร็ว เนื่องจากหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วจะช่วยป้องกันการเสียหายของข้อที่อักเสบได้ โดยแพทย์จะตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมทั้งปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติในครอบครัว และการเป็นเพศหญิง ซึ่งการรักษาที่ช้าไปหรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้ข้อถูกทำลายเสียหายจนผู้ป่วยพิการได้

เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรค แพทย์อาจเลือกการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อทรมาน หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรคเพื่อให้โรคเข้าสู่ระยะสงบ หรืออาจใช้ยาชีวภาพลดปริมาณสารคัดหลั่งที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ ให้กลับเข้าสู่ระดับปกติ รวมถึงการรักษาด้วยยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรง แม้ว่าอาจส่งผลข้างเคียงในระยะยาวได้

นอกจากการใช้ยาเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์แล้ว แพทย์ยังอาจเลือกใช้วิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาควบคู่กันไปด้วย ตั้งแต่การให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยว่าโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์คืออะไร มีพัฒนาการของโรคเป็นเช่นใด ผู้ป่วยจะต้องรับการรักษาอย่างไรบ้าง และผู้ป่วยควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อทะนุถนอมข้อของตนเอง รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันที่จะไม่ให้ข้อรับแรงกดมากเกินไป การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อ ตลอดจนการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลีย

ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เรื้อรัง จนเยื่อบุข้ออักเสบเรื้อรังและโครงสร้างของข้อเสียหาย มีอาการปวดจนทนไม่ได้ ข้อฝืด หรือมีมุมของการเคลื่อนไหวข้อที่ลดลงแล้ว แพทย์อาจต้องตัดสินใจผ่าตัดเพื่อลดการกดเบียดเส้นประสาท หรือเปลี่ยนข้อและโครงสร้างต่างๆ รอบข้อเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งความสำเร็จในการผ่าตัดนี้ นอกจากขึ้นอยู่กับความสามารถของแพทย์และสภาพร่างกายผู้ป่วยแล้ว การทำกายภาพบำบัดเพื่อบริหารและฟื้นฟูข้อยังมีความสำคัญอย่างมากต่อผลสำเร็จของการรักษาอีกด้วย

ส่วนเด็กโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ผู้เขียน

๑. บทนำ

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการอักเสบทั้งร่างกาย โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค ตำแหน่งที่มีความผิดปกติเริ่มจากการอักเสบของเยื่อบุข้อ ทำให้เกิดข้ออักเสบและเส้นเอ็นใกล้ข้ออักเสบ นอกจากนี้ยังพบความผิดปกตินอกข้อ เช่น ปุ่มรูมาทอยด์ (rheumatoid nodules) มีอาการซีด การอักเสบของเนื้อปอด เยื่อหุ้มหัวใจ และเยื่อหุ้มปอด อาการปากแห้งตาแห้ง และตาอักเสบ ความเจ็บปวดของข้อทำให้การทำงานของข้อเสียไป ทั้งในด้านการเคลื่อนไหวและการรับน้ำหนัก อาการของผู้ป่วยจะมีมากขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งมีความพิการของข้อเกิดขึ้น ทำให้สมรรถภาพการเคลื่อนไหวและการทำงานของร่างกายลดลง

เพื่อความเข้าใจว่าข้ออักเสบรูมาทอยด์เป็นอย่างไรจึงจำเป็นต้องรู้จักข้อที่ปกติก่อน ข้อหรือข้อต่อ คือ บริเวณที่กระดูก ๒ ท่อนมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย และความมั่นคงในการถ่ายโอนน้ำหนักหรือแรงที่มากระทำผ่านข้อ ข้อประกอบด้วย กระดูกอ่อน (cartilage) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ปกคลุมปลายกระดูกแต่ละท่อน และเยื่อบุข้อ (synovium membrane) ซึ่งบุอยู่ภายในข้อ มีหน้าที่สร้างของเหลวออกมาเพื่อหล่อลื่นข้อ ทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้นุ่มนวล

ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ เยื่อบุข้อจะเกิดการอักเสบ และแบ่งตัวเพิ่มความหนาขึ้น รวมทั้งมีการสร้างของเหลวเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดอาการปวด บวม และข้อขัด เลือดที่มาเลี้ยงข้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการอักเสบ ทำให้บริเวณข้อร้อนขึ้น เมื่อกระบวนการอักเสบนี้เกิดขึ้นแบบเรื้อรัง จะเกิดการหลั่งสารออกมาทำลายกระดูกและกระดูกอ่อนบริเวณรอบๆ ข้อ ทำให้เกิดการกร่อนของกระดูก อีกทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ของข้อก็ถูกทำลายเช่นกัน เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่ออ่อนรอบข้อจะฝ่อลีบลง ข้ออักเสบเป็นได้เกือบทุกข้อของร่างกาย แต่ข้อที่อักเสบบ่อย ได้แก่ ข้อมือ ข้อโคนนิ้วมือ ข้อกลางนิ้วมือ ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อนิ้วเท้า

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีโอกาสเกิดได้กับประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเกิดได้กับทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ที่มีอายุมากกว่า ๑๖ ปีขึ้นไป และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในอัตราส่วนหญิงต่อชายเท่ากับ ๓ - ๕ : ๑

๒. สาเหตุของการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคยังไม่ทราบ แต่จากการศึกษาเชื่อว่าโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เกิดจากสาเหตุหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค

๒.๑ พันธุกรรม มีความสำคัญต่อการเกิดโรค จากการศึกษาพบว่า ฝาแฝดไข่ใบเดียวกันเมื่อคนหนึ่งเป็นโรค อีกคนก็มีโอกาสเป็นถึงร้อยละ ๑๕-๓๐ ส่วนฝาแฝดไข่คนละใบเมื่อคนหนึ่งเป็นโรค อีกคนก็มีโอกาสเป็นร้อยละ ๓-๑๐ ดังนั้นฝาแฝดไข่ใบเดียวกันจึงมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าฝาแฝดไข่คนละใบราว ๔ เท่า นอกจากนี้ลูกที่เกิดจากผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงกว่าประชากรทั่วไปราว ๑๖ เท่า แสดงว่าพันธุกรรมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคนี้

๒.๒ ฮอร์โมน มีหลักฐานหลายอย่างที่สนับสนุนว่าฮอร์โมนมีบทบาทต่อการเกิดโรค เช่น เพศหญิงเป็นบ่อยกว่าเพศชาย โดยมีอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย ๓-๕ : ๑ การรับประทานยาคุมกำเนิดช่วยให้การเกิดโรคลดลง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์จะมีอาการดีขึ้นขณะตั้งครรภ์ และโรคกำเริบขึ้นภายหลังคลอดบุตรแล้ว นอกจากนี้การเริ่มเป็นโรคขณะเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย อย่างไรก็ตาม กลไกการทำงานของฮอร์โมนที่มีต่อโรคยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนัก

๒.๓ สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงทางพันธุกรรม พบว่าไม่ได้แสดงออกถึงการเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เสมอไปทุกคน แสดงว่าสิ่งแวดล้อมน่าจะมีบทบาทร่วมด้วยในการเกิดโรค ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาบางประเทศในทวีปแอฟริกา นำมาเป็นสมมติฐานได้ว่าอากาศและความเป็นอยู่ในเมือง (urbanization) อาจมีผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรคด้วย ในซีกโลกด้านเหนือ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มักพบในช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาว่าโรคนี้พบบ่อยในฤดูใด

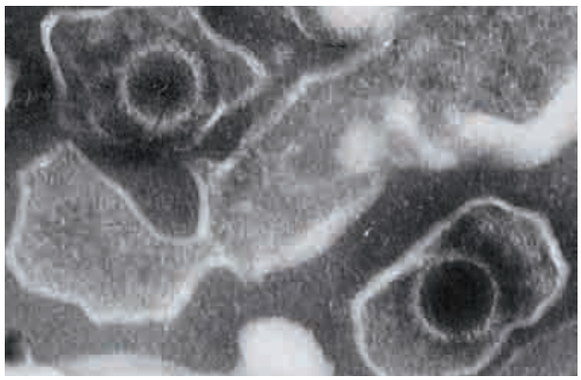
สิ่งที่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ด้วยอีกอย่างหนึ่ง คือ บุหรี่ ถึงแม้ว่ากลไกการเกิดโรคนี้จากบุหรี่ยังไม่กระจ่างนักก็ตาม แต่ผลการศึกษาจากกล้องส่องปอดในผู้ที่สูบบุหรี่ พบซิทรูลลิเนเท็ดเพปไทด์ (citrullinated peptides) ได้ในตัวอย่างการตรวจน้ำ และสารดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารต่อต้านซิทรูลลิเนเท็ดเพปไทด์ ซึ่งการกระตุ้นระบบซ้ำๆ สามารถทำให้เกิดภูมิต่อต้านตัวเอง และนำไปสู่การเกิดโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ได้

๒.๔ เชื้อโรค อาการนำก่อนการเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ได้แก่ อาการปวดข้อหลายข้อ อ่อนเพลีย และมีไข้ต่ำๆ ซึ่งอาการเหล่านี้คล้ายกับอาการติดเชื้อ แต่ไม่สามารถเพาะเชื้อโรคจากข้อได้ เชื้อโรคที่มีผลต่อการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ คือ เชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย สำหรับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค ได้แก่ ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) ไวรัสหัดเยอรมัน (rubella virus) และพาร์โวไวรัส (parvovirus) ส่วนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค ได้แก่ ไมโคพลาสมา (mycoplasma) เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria) เชื้อแบคทีเรียลำไส้ (enteric organism) โดยส่วนของเชื้อแบคทีเรียที่ตายแล้วนั้น ได้แก่ ผนังเซลล์

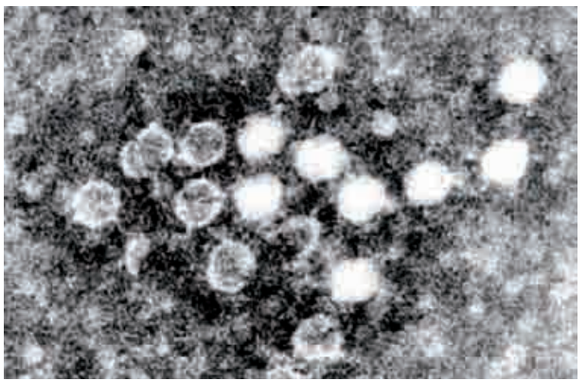
สารพิษ (toxin) และส่วนต่างๆ ของแบคทีเรีย สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของข้อได้ ทั้งนี้ จากการศึกษาโดยการฉีดผนังเซลล์ของแบคทีเรียเข้าไปในสัตว์ทดลอง พบว่าทำให้เกิดข้ออักเสบเรื้อรังแบบโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ในสัตว์ทดลองนั้น

สำหรับกรณีของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์กับโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ โดยในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์พบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ส่วนพาร์โวไวรัสบี ๑๙ (Parvovirus B 19) ก็เป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ โดยพบดีเอ็นเอของไวรัสชนิดนี้ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ได้มากกว่าประชากรทั่วไป



ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์



พาร์โวไวรัสบี ๑๙

๓. ลักษณะทางคลินิกของโรค

ลักษณะทางคลินิกของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีได้หลากหลาย ในผู้ป่วยแต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน แม้ในผู้ป่วยคนเดียวกันแต่ต่างเวลากันก็มีลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกัน การเริ่มต้นของโรคมักค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายสัปดาห์ บางรายมาพบแพทย์ด้วยอาการของโรคที่เป็นข้ออักเสบหลายข้อเฉียบพลัน ส่วนอาการข้ออักเสบเฉียบพลันข้อเดียวมักไม่ค่อยพบ ในระยะแรกของโรค การพบข้อที่เป็นแบบสมดุลทั้ง ๒ ซีกของร่างกาย (ซ้าย-ขวา) มักไม่ชัดเจน แต่ในระยะที่โรคเป็นมาพอสมควรมักเห็นชัดเจนขึ้น

๓.๑ อาการของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ในระยะแรก สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบดังนี้

๑) อาการเริ่มต้นข้ออักเสบแบบค่อยเป็นค่อยไป การเริ่มต้นของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายสัปดาห์ พบร้อยละ ๕๐ - ๗๐ อาจมีอาการเฉพาะที่ข้อ หรือมีอาการของร่างกายอย่างอื่นร่วมด้วย ได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก

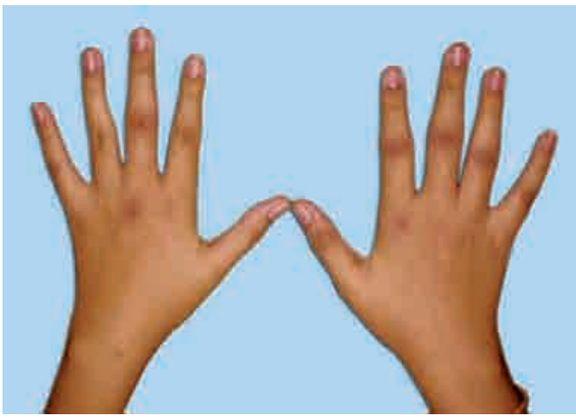
๒) อาการเริ่มต้นข้ออักเสบแบบเฉียบพลัน การเริ่มต้นของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่เป็นแบบเฉียบพลันพบได้ร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรงคล้ายกับกล้ามเนื้อขาดเลือดไปเลี้ยง การวินิจฉัยโรคที่มีอาการแบบนี้ทำได้ยาก เนื่องจากผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยระยะเวลาที่เป็นโรคไม่ถึง ๖ สัปดาห์ ดังนั้นควรทำการวินิจฉัยแยกโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มาพบด้วยอาการลักษณะนี้ เช่น การติดเชื้อ หลอดเลือดอักเสบ

๓) อาการเริ่มต้นแบบกึ่งเฉียบพลัน คือ เป็นอาการระหว่างแบบเฉียบพลันกับแบบค่อยเป็นค่อยไป โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่เป็นแบบลักษณะนี้พบได้ร้อยละ ๒๐ โดยอาจเป็นหลายวันถึงหลายสัปดาห์ อาการของร่างกายทั่วตัวพบได้มากกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไป

๓.๒ อาการทางคลินิกของข้อแต่ละข้อ

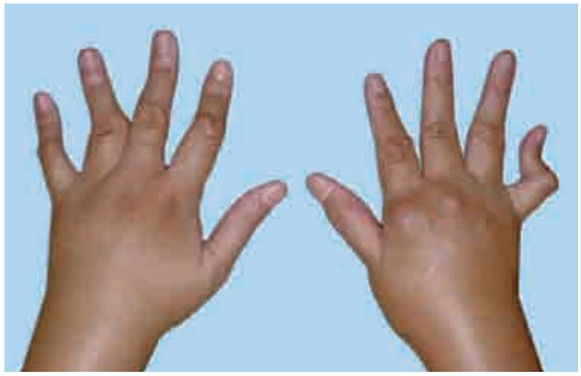
การอักเสบของเยื่อบุข้อทำให้เกิดอาการทางคลินิก คือ ปวด บวม แดง ร้อน ข้อฝืดแข็ง และโครงสร้างของข้อเสียไป ทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา ลักษณะความพิการของแต่ละข้อแตกต่างกันตามโครงสร้างและหน้าที่ของข้อนั้นๆ

๑) มือและข้อมือ ข้อมือ ข้อโคนนิ้วมือ และข้อกลางนิ้วมือ เป็นตำแหน่งข้อที่พบการอักเสบบ่อยที่สุดในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ส่วนข้อปลายนิ้วมือมักไม่อักเสบ ข้อกลางนิ้วมือบวมรูปกระสวย (fusiform swelling) เป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้ในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ และอยู่ในระยะเริ่มแรกของโรค ระยะต่อมาข้อกลางนิ้วมือจะบวมมากขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคมานาน ข้อมือจะบวมมากและมีความพิการของมือและข้อมือดังนี้



ข้อกลางนิ้วมือบวมรูปกระสวย ในระยะเริ่มแรกของโรค

ข้อกลางนิ้วมือจะบวมมากขึ้นในระยะต่อมา



ข้อมือบวมมากในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคมานานจนเริ่มเกิดความพิการ

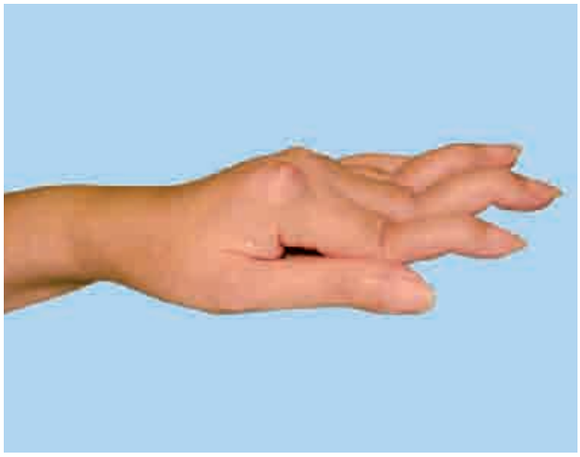
- *นิ้วมือเอนไปทางด้านนอก* คือ นิ้วมือเอนไปทางด้านนอกของข้อโคนนิ้วมือ เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง

- *นิ้วมือผิดรูปแบบรูปคอห่าน* คือ ข้อปลายนิ้วมืองอพับ ส่วนข้อกลางนิ้วมือมีลักษณะเหยียดตรง

- *นิ้วผิดรูปแบบบูทอนเนียร์ (Boutounniere deformities)* คือ มีลักษณะข้อกลางนิ้วมืองอพับและข้อปลายนิ้วมือเหยียดตรง

- *กลุ่มอาการคาร์ปาลทันเนล (carpal tunnel syndrome)* เกิดจากเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) ที่ผ่านอุโมงค์ข้อมือ (carpal tunnel) ถูกกดทับ ทำให้เกิดอาการปวดหรือชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง กล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือลีบและอ่อนแรง

นิ้วมือเอนไปทางด้านนอก

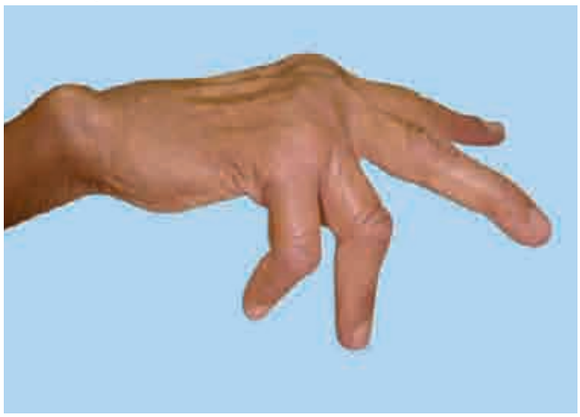


นิ้วมือผิดรูปแบบรูปคอห่าน

นิ้วมือผิดรูปแบบรูปคอห่าน

นิ้วมือผิดรูปแบบบูทอนเนียร์ที่นิ้วกลางและนิ้วนาง และแบบรูปคอห่านที่นิ้วชี้

- *เส้นเอ็นเหยียดนิ้วขาด* เกิดจากเยื่อบุข้อที่หนาตัวขึ้นในตำแหน่งข้อมือไปเบียดเส้นเอ็นที่ผ่านข้อมือ ทำให้เส้นเอ็นเสียดสีกับปุ่มกระดูกจนเส้นเอ็นขาด ทำให้ไม่สามารถกระดกนิ้วมือได้ทันที แต่ไม่มีอาการปวด ตำแหน่งที่พบเส้นเอ็นเหยียดนิ้วขาดบ่อยๆ คือ เส้นเอ็นของนิ้วก้อย นิ้วนาง และนิ้วกลาง



เส้นเอ็นของนิ้วก้อย และนิ้วนางขาด ไม่สามารถกระดกนิ้วได้

๒) ข้อศอก เป็นข้อซึ่งพบในระยะแรกของโรค เนื่องจากข้อนี้อยู่ใกล้ผิวหนัง ตรวจพบว่ามีเยื่อบุข้อที่หนาขึ้นทางด้านหลังของข้อศอก ซึ่งการอักเสบของข้อศอกทำให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อลดลง ผู้ป่วยมักไม่สามารถเหยียดข้อศอกได้ตรง หรืองอข้อศอกได้ไม่เต็มที่

๓) ข้อไหล่ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่มีอาการของเยื่อบุข้อไหล่อักเสบ จะมีผลต่อกระดูกไหปลาร้าที่เชื่อมต่อกับข้อไหล่ ถุงน้ำรอบข้อไหล่และกล้ามเนื้อที่อยู่ในบริเวณคอและหน้าอกส่วน

บน ข้อไหล่ที่อักเสบจะมีลักษณะกดเจ็บบริเวณข้อไหล่ ปวดเวลากลางคืน และมีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลง การบวมมักเห็นได้จากด้านหน้าของข้อไหล่ ซึ่งความเสียหายของข้อไหล่ทำให้เกิดอาการปวดข้อไหล่ทั้งขณะเคลื่อนไหวและขณะพัก

ข้อบวมด้านตาตุ่มในของข้อเท้า

๔) ข้อเท้าและข้อนิ้วเท้า การอักเสบของข้อเท้าและข้อนิ้วเท้าจะมีผลต่อการทำงานของร่างกายและจะมีอาการปวดมากกว่าการอักเสบของข้อส่วนบนของร่างกาย เพราะข้อเท้าและข้อนิ้วเท้าต้องทำหน้าที่ในการรับน้ำหนัก และการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยมีข้อบวมด้านตาตุ่มในของข้อเท้า และด้านตาตุ่มนอกของข้อเท้า ความพิการที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ ได้แก่ นิ้วเท้ากระดกขึ้น ผิวหนังด้านบนของนิ้วเท้าเสียดสีกับรองเท้าทำให้เกิดแผลได้ง่าย การเคลื่อนหลุดจากตำแหน่งของหัวกระดูกโคนนิ้วเท้าทำให้หัวกระดูกโคนนิ้วเท้ากดลงที่ฝ่าเท้า เกิดอาการปวดของผิวหนังที่ถูกกดทับ ผู้ป่วยมีอาการปวดเวลาเดิน นอกจากนี้การกดทับทำให้เกิดแผลที่ฝ่าเท้า เส้นประสาททิเบียลด้านหลัง (posterior tibial nerve) ถูกกดทับจากเยื่อบุข้ออักเสบ ทำให้เกิดอาการชาของฝ่าเท้า และอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่ออยู่ในท่ายืนหรือเดิน

ข้อบวมด้านตาตุ่มนอกของข้อเท้า

ความพิการของนิ้วเท้าที่กระดกขึ้นจึงเกิดการเสียดสีกับรองเท้า ทำให้เกิดแผลง่าย

๕) ข้อเข่า ข้อบวมจากเยื่อบุข้ออักเสบหนาตัวขึ้นและมีน้ำไขข้อมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าลีบและอ่อนแรงกว่าปกติ มุมการ

แผลที่เกิดจากการกดทับบริเวณฝ่าเท้า

เคลื่อนไหวข้อเข่าลดลงทำให้ไม่สามารถเหยียดเข่าตรงได้ เป็นเหตุให้ข้อเข่าทำงานได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งมุมในการเหยียดเข่าก็ลดลงและอยู่ในท่างอข้อเข่า ทำให้ความดันในข้อเข่าเพิ่มขึ้น การมีน้ำมากและดันออกทางด้านหลังของข้อเข่าทำให้เกิดถุงน้ำที่ข้อพับเข่า ซึ่งหากได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง ถุงน้ำอาจแตกไปที่น่องทำให้น่องบวมโต ผู้ป่วยบางรายที่เป็นมากและไม่เคลื่อนไหวข้อทำให้ข้อเข่างอพับ ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อได้

ข้อเข่าทั้งสองข้างบวมและมีน้ำไขข้อมากกว่าปกติ

ถุงน้ำที่ข้อพับเข่าแตกไปที่น่อง ทำให้น่องข้างขวาบวมโต

๖) ข้อสะโพก ข้อสะโพกเป็นข้อที่อยู่ลึก จึงไม่สามารถตรวจว่ามีอาการบวม หรือมีการหนาตัวของเยื่อบุข้อได้ ในระยะแรกของการเป็นโรคมักไม่ค่อยมีการอักเสบของข้อสะโพก เมื่อโรคเป็นมากขึ้นจึงพบว่ามีการอักเสบ หากข้อสะโพกมีการอักเสบเรื้อรัง หัวกระดูกสะโพกจะเกิดการยุบตัว บางรายหัวกระดูกสะโพกดันเบ้ากระดูกจนหัวกระดูกสะโพกยื่นเข้าสู่ด้านใน เรียกภาวะนี้ว่ากระดูกสะโพกทะลุเบ้า (protrusio acetabuli)

๗) ข้อกระดูกสันหลัง การเปลี่ยนแปลงของข้อกระดูกสันหลังระดับคอเป็นตำแหน่งที่พบได้บ่อยกว่ากระดูกสันหลังระดับอกและเอว อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยที่มีการอักเสบของข้อ

ข้อเข่างอพับจนไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อได้

กระดูกสันหลังระดับคอ คือ มีอาการคอฝืด คอแข็ง และเคลื่อนไหวคอได้ลำบาก อาการที่พบบ่อยในเวลาต่อมา คือ การปวดคอร้าวไปที่ท้ายทอย อาการที่พบรองลงมา คือ แขนขามีอาการอ่อนแรง พร้อมทั้งมีอาการเกร็งแข็ง และการรับความรู้สึกของมือเสียไป อาจมีอาการชาบริเวณไหล่หรือแขนขณะที่เคลื่อนไหวศีรษะ

๘) ข้อพิการ ความพิการของข้อเกิดขึ้นจากการที่โครงสร้างของข้อเสียหาย และสิ่งที่ประกอบเป็นข้อถูกทำลายจากกระบวนการอักเสบของข้อ ข้อเล็กๆ บริเวณมือและเท้าเป็นตำแหน่งที่พบข้อพิการได้บ่อย โดยพบว่าผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ ๑๐ มีข้อพิการของข้อเล็กๆ ภายในระยะเวลา ๒ ปีของการเป็นโรค และข้อพิการเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป

๙) โครงสร้างข้อถูกทำลาย การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุข้อทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อบางลง และกระดูกที่อยู่ใกล้ข้อกร่อนแหว่ง ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างข้อที่ถูกทำลาย ลักษณะทางคลินิกที่แสดงว่าโครงสร้างข้อถูกทำลายคือรูปร่างของข้อเสียไป ข้อพิการและมีการสูญเสียการทำงานของข้อ โครงสร้างที่เสียหายแล้วไม่สามารถกลับสู่สภาพปกติได้อีก และจะยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หลักฐานที่แสดงว่ามีการทำลายกระดูกอ่อนคือ ในการตรวจจะรู้สึกมีเสียงดังแกร๊กๆ เวลาเคลื่อนไหวข้อ หรือหากเอกซเรย์จะพบช่องว่างระหว่างข้อหายไป

๑๐) กล้ามเนื้อที่อยู่รอบข้อลีบ ประสิทธิภาพและกำลังของกล้ามเนื้อลดลง อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อไม่ได้สัดส่วนกับอาการข้ออักเสบ คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากเกินไป

๑๑) ตัวร้อน เป็นอาการที่พบได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบหลายข้อและเป็นรุนแรง

๑๒) น้ำหนักตัวลดลง เป็นอาการที่พบได้ในช่วงที่โรคยังไม่ได้รับการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเบื่ออาหาร

๑๓) ประสิทธิภาพของร่างกายลดลง ร่างกายทำงานได้น้อยลง การทำงานของร่างกายที่ต้องใช้ข้อมากทำให้ข้ออักเสบเป็นมากขึ้นจนผู้ป่วยบางรายต้องหยุดงาน และบางรายต้องเปลี่ยนอาชีพเนื่องจากร่างกายทำงานหนักไม่ได้ การทำกิจวัตรประจำวันมีประสิทธิภาพที่ลดลง เช่น การแต่งตัว การเปิด-ปิดประตู การขึ้น-ลงบันได การเดินบนพื้นราบ การลุก-นั่ง

๓.๓ อาการทางคลินิกนอกข้อ

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย อาการนอกข้อเป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น ผิวหนัง ตา ปอด ไต หัวใจ กระดูก ระบบประสาท ระบบโลหิตวิทยา อาการนอกข้อที่พบบ่อยที่สุด คือ ปุ่มรูมาทอยด์ พบได้ร้อยละ ๕ - ๒๐ ความชุกของอาการนอกข้อเป็นไปตามความรุนแรงของโรคและระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นโรค อาการนอกข้อในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีแสดงไว้ในตารางที่ ๑

ปุ่มรูมาทอยด์บริเวณข้อศอก

ตารางที่ ๑ อาการนอกข้อในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่เกิดกับอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย

อวัยวะ	ลักษณะทางคลินิก
ผิวหนัง	ปุ่มรูมาทอยด์ ผิวหนังเปราะบาง หลอดเลือดอักเสบ
ตา	กลุ่มอาการตาแห้ง เยื่อชั้นบนตาขาวอักเสบ ตาขาวอักเสบ ตาขาวบาง-ทะลุ ตาดำเป็นแผล
ระบบหายใจและปอด	การอักเสบของข้อต่อกล่องเสียง เยื่อหุ้มปอดอักเสบ น้ำในช่องปอด พังผืดแทรกในปอด (interstitial lung disease) ปุ่มในเนื้อปอด หลอดเลือดอักเสบ
หัวใจ	เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หลอดเลือดแดงมีการแข็งตัวก่อนเวลา หลอดเลือดอักเสบ ลิ้นหัวใจมีปุ่ม
ระบบประสาท	เส้นประสาทถูกกดทับ ไขสันหลังส่วนคอผิดปกติ เส้นประสาทเส้นเดียวอักเสบ แบบซับซ้อน ประสาทส่วนปลายผิดปกติ
กระดูก	กระดูกอ่อนผิวข้อบางลง
ระบบโลหิตวิทยา	ภาวะโลหิตจาง ภาวะเกล็ดเลือดมาก ต่อมน้ำเหลืองโต กลุ่มอาการเฟลตี (Felty's syndrome)
ไต	ภาวะแอมีลอยโดสิส (amyloidosis) หลอดเลือดอักเสบ

๑) ปุ่มรูมาทอยด์ (rheumatoid nodules)

เป็นอาการนอกข้อที่พบได้บ่อยที่สุด ในคนผิวขาวพบประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ส่วนในคนผิวเหลืองพบน้อยกว่าคนผิวขาว สำหรับประเทศไทยพบราวร้อยละ ๔ - ๑๐

ปุ่มรูมาทอยด์เป็นปุ่มก้อนที่ผิวหนัง โดยจัดแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดตื้น และชนิดลึก ส่วนตำแหน่งที่พบคือ ตำแหน่งกดทับ เช่น ข้อศอก ก้นกบ ศีรษะ ส้นเท้า มีลักษณะเป็นปุ่มเดียวหรือหลายปุ่ม ปุ่มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ - ๕ มิลลิเมตร ถึง ๒ - ๓ เซนติเมตร

หลอดเลือดอักเสบที่ปลายนิ้ว

มักไม่เจ็บ ผู้ที่เป็นปุ่มรูมาทอยด์หลายปุ่มมักเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่รุนแรงและเป็นมานาน ปุ่มรูมาทอยด์อาจเกิดขึ้นช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป หรือเกิดขึ้นทันทีทันใดก็ได้ และสามารถหายได้เอง โดยค่อยๆ ฝ่อตัวลงจนหายไปในที่สุด

๒) หลอดเลือดอักเสบ (vasculitis)

ลักษณะทางคลินิกของหลอดเลือดอักเสบในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดเลือดและตำแหน่งที่เป็น มักเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

- *หลอดเลือดอักเสบที่ผิวหนัง* ได้แก่ รอยโรคที่ขอบเล็บเป็นผื่นนูนคลำรู้สึกได้ ผิวหนังเป็นแผลจากการขาดเลือด และอาการปลายนิ้วขาดเลือดจนเกิดนิ้วตาย

- *หลอดเลือดอักเสบที่ตา* ที่พบ ได้แก่ ตาขาวอักเสบ

- *หลอดเลือดอักเสบที่หัวใจ* ที่พบ ได้แก่ หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย

๓) อาการทางตา

- *อาการตาแห้ง* พบบ่อยในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ เป็นอาการที่ค่อยเป็นค่อยไป และหายได้เองในระยะแรก แต่ในระยะหลังมักไม่หาย แพทย์ต้องคอยถามผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการตาแห้ง และเริ่มให้การรักษาเมื่อมีอาการ

- *เยื่อชั้นบนตาขาวอักเสบ* พบได้ที่ตาขาวด้านหน้า อาจเป็นหย่อมๆ หรือเป็นทั่วตา ผู้ป่วยมีความรู้สึกเคืองตา อาการมักเป็นชั่วคราวหรือเป็นสัปดาห์ แต่บางรายอาจเป็นนานหลายเดือน

- *ตาขาวอักเสบ* เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าอาการตาแห้ง และอาจตามมาด้วยอาการปวดลูกตา ต่อมามีการตายของเนื้อเยื่อตาขาว

- *ตาขาวบาง-ทะลุ* มีอาการค่อยๆ เป็น โดยผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บ มีการทำลายเยื่อตาขาวอย่างช้าๆ จนเยื่อตาขาวบางลงและทะลุ พบในตำแหน่งด้านบนของลูกตาด้านหน้า

๔) ระบบหายใจและปอด

- *การอักเสบของข้อต่อกล่องเสียง* เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ มีอาการได้แก่ เจ็บคอ เสียงแหบ เจ็บเวลากลืนอาหาร อาการมักเป็นมากในตอนเช้า และดีขึ้นในช่วงสาย

- *เยื่อหุ้มปอดอักเสบ* ทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้า-ออก จากการตรวจผู้ป่วยเมื่อเสียชีวิตแล้วพบว่ามีอาการเยื่อหุ้มปอดหนาร้อยละ ๕๐ อาการเยื่อหุ้มปอดหนาและเยื่อหุ้มปอดอักเสบทั้งสองข้างร้อยละ ๒๕ ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการ แต่ตรวจพบมีน้ำในช่องปอดจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ ซึ่งน้ำในช่องปอดมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ระดับน้ำตาลต่ำ โปรตีนสูง เม็ดเลือดขาวน้อยกว่า ๕๐๐ เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร

- *พังผืดแทรกในปอด* การตรวจทางเอกซเรย์ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์พบพังผืดแทรกบริเวณฐานปอด โดยในระยะแรกมักไม่มีอาการ แต่ถ้าเป็นมาก พังผืดจะแทรกทั่วปอด ทำให้มีอาการเหนื่อยหอบได้

- *ปุ่มในเนื้อปอด* พบได้ประมาณร้อยละ ๓๐ ปุ่มก้อนที่พบในเนื้อปอดมีอันเดียวหรือหลายอัน ปุ่มใกล้เยื่อหุ้มปอดจะพบน้อย

๕) หัวใจ

- *เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ* พบได้บ่อย และผู้ป่วยไม่มีอาการ มักพบจากการตรวจเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่เสียชีวิตจากหลอดเลือด เชื่อว่าเป็นผลจากการที่หลอดเลือดแดงแข็งตัวก่อนเวลาจากการเป็นโรคเรื้อรัง หรือมีหลอดเลือดอักเสบ ซึ่งจากการบันทึกภาพของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (echocardiography) พบว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจมากกว่าปกติ (pericardial effusions) ได้เกือบร้อยละ ๕๐ ทั้งๆ ที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ นอกจากนี้ยังอาจมีปุ่มรูมาทอยด์เกิดที่กล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ

๖) ระบบประสาท

อาการทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีพื้นฐานจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- *กระดูกสันหลังคอไม่มั่นคง*
- *เส้นประสาทถูกกดทับ*
- *หลอดเลือดอักเสบทำให้เกิดเส้นประสาทเส้นเดียวอักเสบแบบซับซ้อน*

อาการทางระบบประสาทที่พบบ่อยในผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มานาน คือ มือทั้งสองข้างมีอาการชาและอ่อนแรง

๗) ระบบโลหิตวิทยา

- *ภาวะโลหิตจาง* หรืออาการซีดที่พบบ่อยในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ เป็นแบบเม็ดเลือดแดงขนาดปกติและสีปกติ ผู้ป่วยร้อยละ ๗๕ เป็นผลจากการเป็นโรคเรื้อรัง และร้อยละ ๒๕ เป็นผลจากการขาดธาตุเหล็ก บางส่วนอาจมีผลจากการขาดวิตามินบี ๑๒ ร่วมด้วย

- *ภาวะเกล็ดเลือดมาก* มักเกิดขึ้นในขณะที่โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์อยู่ในระยะกำเริบ โดยเกล็ดเลือดที่มีจำนวนมากนี้มักมีอายุการทำงานสั้นกว่าปกติ

- *ต่อมน้ำเหลืองโต* อาจพบในตำแหน่งที่สามารถคลำได้เพราะอยู่ใกล้ผิวหนัง และตำแหน่งที่ไม่สามารถคลำได้เพราะอยู่ในส่วนลึกของร่างกาย ตำแหน่งที่พบบ่อย คือ เหนือศอก รักแร้ และคอ ซึ่งจากการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์มักพบเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ขยายตัวขึ้น

- *กลุ่มอาการเฟลตี* เป็นกลุ่มอาการที่มีอาการของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เรื้อรัง ม้ามโต และเม็ดเลือดขาวต่ำ จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร พบในผู้ป่วยที่มีอาการนอกข้อรุนแรง ได้แก่ ปุ่มรูมาทอยด์ น้ำหนักลด ต่อมน้ำเหลืองโต มีแผลที่ขา เยื่อหุ้มปอดอักเสบ และผิวหนังมีสีเข้มขึ้น

๘) ไต

อาการทางไตจากโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์พบน้อยมาก มักพบเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงของยาบางชนิด ที่สำคัญคือ ภาวะแอมีลอยโดสิสที่พบร่วมกับหลอดเลือดอักเสบและการติดเชื้อ เป็นภาวะที่คุกคามชีวิต ความผิดปกติของไตคือ มีโปรตีนมากในปัสสาวะ บางรายการทำงานของไตเสียไปเกิดภาวะไตวาย นอกจากนี้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ยังสามารถทำให้การทำงานของไตเสียได้

๔. การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์อาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแยกโรคอื่นออกไป ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดข้อ ข้อที่อักเสบมีหลายข้อ เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ลักษณะของข้อที่เป็นในระยะแรก ได้แก่ ข้อบวม เมื่อกดหรือคลำจะรู้สึกเจ็บ มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง และข้อฝืดแข็งอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ข้ออักเสบเป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของร่างกายอย่างสมดุลกัน อายุที่เริ่มเป็นโรคอยู่ระหว่าง ๑๘ - ๖๔ ปี เพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายประมาณ ๓ - ๕ : ๑ ซึ่งเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ของสมาคมโรคข้อแห่งสหรัฐอเมริกา (American Rheumatology Association) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีรายละเอียดระบุไว้ในตารางที่ ๒ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์จะต้องมีเกณฑ์อย่างน้อย ๔ ใน ๗ ข้อ โดยเกณฑ์ข้อ ๑ - ๔ ต้องเป็นอย่างน้อย ๖ สัปดาห์

ตารางที่ ๒ เกณฑ์การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ของสมาคมโรคข้อแห่งสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๐

เกณฑ์	คำจำกัดความ
๑. ข้อฝืดแข็งในตอนเช้า	ข้อฝืดแข็งที่ข้อและรอบข้อเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ก่อนดีขึ้นเต็มที่
๒. ข้ออักเสบ ๓ ข้อ หรือมากกว่า	ข้ออักเสบ โดยข้อบวมจากเยื่อบุข้อ และน้ำไขข้อ (ไม่ใช่เกิดจากกระดูกงอก) ตรวจพบโดยแพทย์ เป็นพร้อมกันอย่างน้อย ๓ ข้อจาก ๑๔ ข้อ ได้แก่ ข้อกลางนิ้วมือ ข้อโคนนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้าและข้อโคนนิ้วเท้า (ซ้าย-ขวาของร่างกาย)
๓. ข้ออักเสบของข้อบริเวณมือ	ข้ออักเสบโดยมีลักษณะบวม (ตามที่กล่าวในข้อ ๒) อย่างน้อย ๑ ข้อ ในตำแหน่งข้อมือ ข้อโคนนิ้วมือ หรือข้อกลางนิ้วมือ
๔. ข้ออักเสบทั้ง ๒ ข้างมีลักษณะแบบสมดุล	ข้ออักเสบ (ตามที่กล่าวในข้อ ๒) ในตำแหน่งเดียวกันทั้ง ๒ ข้างของร่างกาย ในกรณีที่เป็น ๒ ข้างของข้อกลางนิ้วมือ ข้อโคนนิ้วมือ ข้อโคนนิ้วเท้า ก็เป็นที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีความสมดุลของ ๒ ข้างแบบสมบูรณ์
๕. ปุ่มรูมาทอยด์ (rheumatoid nodules)	ตรวจพบโดยแพทย์ พบปุ่มใต้ผิวหนังเหนือตำแหน่งกระดูกที่โปนเด่น หรือบริเวณผิวหนังด้านเหยียดข้อ (extensor) หรือในบริเวณรอบข้อ
๖. พบรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด	ตรวจเลือดพบรูมาทอยด์แฟกเตอร์ผลบวกด้วยวิธีการตรวจใดก็ตามที่เมื่อตรวจในคนปกติให้ผลบวกน้อยกว่าร้อยละ ๕
๗. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเอกซเรย์	ภาพเอกซเรย์ของมือและข้อมือพบการเปลี่ยนแปลงที่เข้าได้กับกรณีของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ซึ่งได้แก่ การกร่อนแหว่งของกระดูก หรือเนื้อกระดูกที่อยู่ใกล้ข้อสูญเสียแคลเซียม

๕. แนวทางการรักษาโรค

ขั้นตอนในการรักษา

แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- การวินิจฉัยโรคเร็ว
- การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
- การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
- การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

๑) การวินิจฉัยโรคเร็ว จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยโรคช้า ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นข้ออักเสบจนถึงการวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์มีตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ จนถึง ๑๐ ปี เฉลี่ย ๓๖ สัปดาห์ ซึ่งการวินิจฉัยโรคและได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วจะช่วยป้องกันการเสียหายของข้อ

๒) การประเมินระดับความรุนแรงของโรค โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ คะแนนการกำเริบของโรค ดัชนีการกำเริบของโรคแบบธรรมดา ดัชนีการกำเริบของโรคทางคลินิก ดัชนีการกำเริบของโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ คะแนนการกำเริบของโรคในผู้ป่วย และข้อมูลดัชนีผู้ป่วยประเมินตามงานประจำ

๓) การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี ได้แก่ การเริ่มเป็นโรคตั้งแต่อายุยังน้อย การทำลายข้อและกระดูกจากภาพรังสีในระยะแรกเริ่มของโรค มีอาการนอกข้อ (extra-articular manifestations) การทำงานของข้อแย่ลงอย่างรวดเร็ว มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ และเป็นเพศหญิง

๔) การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์แบบใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีขั้นตอนตามระดับความรุนแรงของโรค และสามารถจำแนกการรักษาดังนี้

- *การรักษาที่ไม่ใช้ยา* ได้แก่ การให้ความรู้ การพัก การออกกำลังกาย กายภาพบำบัด และการผ่าตัด

- *การรักษาด้วยยา* แบ่งออกได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค (ชนิดไม่ใช่ชีวภาพ และชนิดชีวภาพ) และคอร์ติโคสเตียรอยด์

ก. การรักษาที่ไม่ใช้ยา ได้แก่

๑. การให้ความรู้

สิ่งสำคัญที่สุดของการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ คือ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา แพทย์หลายคนให้ความสำคัญในการรักษามาก ผู้ป่วยที่มีการศึกษาดีมีผลการรักษาดีกว่าผู้ป่วยที่ด้อยการศึกษา ความรู้ที่ให้ผู้ป่วย ได้แก่ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์คืออะไร และมีผลต่อผู้ป่วยอย่างไร การดูแลตัวเอง การพักผ่อน การออกกำลังกายที่เหมาะสม การใช้ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตกับโรค การใช้ข้อที่เหมาะสมเพื่อทะนุถนอมข้อ อาหารที่ควรรับประทาน การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร การดำเนินโรคเป็นอย่างไร ควรได้รับการรักษาอย่างไร และผลข้างเคียงที่สำคัญของยาที่ใช้มีอะไรบ้าง การให้ความรู้สามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ วีดิทัศน์ การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือการดูแลโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ การเข้ากลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

๒. การพัก

ในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ การพักเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป อาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่พบได้บ่อย การได้นอนพัก ๖ - ๘ ชั่วโมงในเวลากลางคืน และ ๑ ชั่วโมงในตอนบ่าย ช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่สดชื่นขึ้น แต่การพักมากไปก็เป็นผลเสียเช่นกัน คือ ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อลีบ และมุมการเคลื่อนไหวของข้อลดลง ดังนั้นผู้ป่วยควรจัดเวลาพักและการใช้ข้อให้เกิดความสมดุล

๓. การออกกำลังกาย และกายภาพบำบัด

การออกกำลังกายมีจุดมุ่งหมาย คือ คงหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ป้องกันและแก้ไขความพิการ คงหรือเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อ และทำให้ข้อยังคงมีการทำงานได้ต่อไป การออกกำลังกายควรให้เหมาะสมกับสภาวะข้ออักเสบที่มี ในขณะที่มีข้ออักเสบควรออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย ใช้การเกร็งกล้ามเนื้อมัดที่ต้องการฝึก โดยการผ่อนแล้วเกร็งใหม่สลับกันไป หรือการออกแรงดึงวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ดันกำแพง ดันโต๊ะ ดึงโต๊ะ การออกกำลังกายที่มีผลต่อการอักเสบของข้อ ความดันภายในข้อ และการทำลายของกระดูกใกล้เคียง รวมทั้งการออกกำลังกายที่มีผลต่อเลือดที่ออกจากหัวใจและทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น ควรทำด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีข้ออักเสบเฉียบพลันหรือมีข้ออักเสบที่รุนแรง และในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจทั้งขณะที่กำลังเริ่มเป็น หรือที่เป็นมาแล้วระยะหนึ่ง การใส่เฝือกหรือเครื่องดาม (splint) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเคลื่อนไหวนั้นควรมีการถอดเฝือกวันละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ข้อมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ จะช่วยให้ข้อไม่ยึดติดกันและป้องกันการหดตัวของเนื้อเยื่ออ่อนรอบๆ ข้อ ดังนั้นการออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลัง

การออกกำลังกายด้วยวิธีดันโต๊ะ

กายแบบไอโซเมตริกก่อน จนอาการข้ออักเสบดีขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหด-คลายตัว และข้อต่อมีการเคลื่อนไหวด้วย เช่น การใช้มือยกสิ่งของขึ้นลง การยกน้ำหนัก นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ควรได้รับคำแนะนำการใช้ข้อในกิจวัตรประจำวันด้วย

ในระยะแรกของข้ออักเสบ ผู้ป่วยควรได้รับการสอนเรื่องการใช้ข้อในกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้ข้อมีระยะการใช้งานได้ยาวนาน ไม่ถูกทำลายก่อนเวลาอันควร หลักการพื้นฐานคือ ในข้อที่รับน้ำหนักไม่ควรให้แรงผ่านข้อมากเกินไป เช่น หลีกเลี่ยงการวิ่งบนพื้นแข็ง การยกของหนัก การปีนเขา ส่วนข้อที่ไม่รับน้ำหนักควรหลีกเลี่ยงการทำงานของกล้ามเนื้อมากเกินไป เช่น การจับหรือถือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนานเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องใช้ที่มีที่จับขนาดเล็ก เช่น ด้ามไม้กวาด ด้ามมีด เพราะต้องใช้แรงมากกว่าเครื่องใช้ที่มีที่จับขนาดใหญ่ นอกจากนี้การยกสิ่งของด้วยมือทั้ง ๒ ข้างดีกว่าการใช้มือข้างเดียว ตลอดจนควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อซ้ำๆ กันนานเกินไป

หลีกเลี่ยงมีดที่มีด้ามจับขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อข้อถูกใช้งานมากเกินไป

ข. การรักษาด้วยยา ได้แก่

๑. ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์

ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เป็นยาที่ช่วยลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ และความทุกข์ทรมาน แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าช่วยป้องกันข้อจากการถูกทำลายในระยะยาว นั่นคือ ยังไม่มีหลักฐานว่ายานี้เปลี่ยนแปลงการดำเนินโรคได้ ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์สามารถลดข้ออักเสบอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลต่อผู้ป่วยแต่ละคนจะแตกต่างกัน รวมทั้งผลข้างเคียงของยาที่มีต่อผู้ป่วยแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันด้วย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยและเป็นอันตราย คือ ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ ๑.๓ - ๑.๖ ต่อการใช้ยา ๑ ปี หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ตลอดช่วงระยะของการเป็นโรค ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงของยาต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อายุที่มากขึ้น การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ร่วมด้วย และการสูบบุหรี่ ในกรณีของผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงให้ใช้ยาที่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อย คือ ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มค็อกซิบ

ข้อบ่งใช้ของยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ได้แก่ อาการปวดข้อและข้ออักเสบ การเลือกยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ควรให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยดูจากประสิทธิภาพของยา ความปลอดภัย ความทนของผู้ป่วยต่อการใช้ยา และราคายา โดยทั่วไปการใช้ยาควรให้เวลาในการใช้ประมาณ ๓ - ๔ สัปดาห์ เพื่อดูถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยา การติดตามผลข้างเคียงของยา ได้แก่ การซักประวัติการปวดท้อง และการขับถ่ายอุจจาระสีดำ การตรวจ

ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจอุจจาระ การตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจการทำงานของตับและไต

๒. ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค

ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคสำหรับโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ คือ ยาที่ทำให้โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้นหรือเข้าสู่ระยะสงบได้ ยากลุ่มนี้มี ๒ ชนิด คือ ชนิดไม่ใช่ชีวภาพ และชนิดชีวภาพ

ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคชนิดไม่ใช่ชีวภาพมีหลายอย่าง เช่น เมโทเทร็กเซต ซัลฟาแซละซีน ไซโคลฟอสฟาไมด์ เลฟลูโนไมด์ ไซโคลสปอริน คลอแรมบิวซิล ไมโอคริซิน ยาในกลุ่มนี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ช้า ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์จนเป็นเดือนก่อนจะเห็นผลการตอบสนองของยา ดังนั้นบางคนจึงเรียกยากลุ่มนี้ว่า *ยาต้านรูมาทิซึมที่ออกฤทธิ์ช้า*

แผนการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ในปัจจุบันมีหลายวิธี ซึ่งคล้ายคลึงกับการรักษาทางเคมีบำบัดในผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง กลยุทธ์ของการรักษา คือ การประเมินระดับความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเป็นและให้การรักษาที่พอดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสหายจากโรค การประเมินประสิทธิภาพของการรักษาโรคอาศัยการดูจากอาการปวดข้อ จำนวนข้ออักเสบ การทำงานของข้อ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการถ่ายภาพเอกซเรย์ อย่างไรก็ดี มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือตอบสนองต่อการรักษาแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ และถึงแม้จะมีงานวิจัยที่ทำให้การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เป็นแบบหายขาดมากกว่าเป็นการรักษาตามอาการ แต่ก็ยังไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ นอกจากนี้การรักษายังมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงของยา ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะในร่างกายล้มเหลว เช่น ไขกระดูก ตับ ไต ซึ่งข้อมูลนี้ผู้ป่วยควรมีส่วนรับรู้ด้วย

ยาชีวภาพ คือ ยาหรือสารที่มีผลโดยตรงต่อสารคัดหลั่งที่ทำให้เกิดการอักเสบ และทำให้สารคัดหลั่งที่มีมากเกินไปนี้ลดลงหรือไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ สารคัดหลั่งที่ทำให้เกิดการอักเสบที่สำคัญในโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ได้แก่ ทูเมอร์เนคโครสิสแฟกเตอร์แอลฟา อินเทอร์ลูคิน-๑ และอินเทอร์ลูคิน-๖ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถผลิตยาหรือสารที่จับกับสารคัดหลั่งที่มีมากเกินได้ ทำให้สารคัดหลั่งที่มีมากเกินกลับเข้าสู่ระดับปกติ การรักษาแบบนี้เรียกว่า *การรักษาด้วยยาชีวภาพ* ในปัจจุบันยาชีวภาพที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ อินฟลิกซิแม็บ (Infliximab) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า เรมิเคด (Remicade) อีแทเนอร์เซ็ปต์ (Etanercept) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า เอ็นเบรล (Enbrel) แอนติซีดี-๒๐ หรือไรทุซิแม็บ (Rituximab) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า แม็บทีรา (Mabthera) และแอนติอินเทอร์ลูคิน-๖ ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า โทลซิลิซุแม็บ (Tolcilizumab)

ดังนั้นการเลือกชนิดของยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคให้เหมาะสมกับผู้ป่วยให้ดูจากระดับความรุนแรงของโรค เช่น จำนวนข้อที่เป็นโรค ความเสียหายของข้อจากการตรวจร่างกาย ภาพถ่ายเอกซเรย์ข้อ ประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของยา ฐานะของผู้ป่วย

กลยุทธ์ของการใช้ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค มีดังนี้

๑) การรักษาแบบคู่ขนาน คือ การใช้ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค ๒ ชนิดพร้อมกัน ตั้งแต่เริ่มการวินิจฉัยโรค และให้ยาไปตลอด

๒) การรักษาแบบค่อยๆ เพิ่มยา คือ การใช้ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค ๑ ชนิดในระยะแรก และหากไม่สามารถควบคุมโรคได้จึงเพิ่มยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคชนิดอื่นเข้าไปร่วมด้วย

๓) การรักษาแบบค่อยๆ ลดยา คือ การใช้ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค ๒ ชนิด หรือมากกว่าตั้งแต่เริ่มการวินิจฉัยโรค เมื่ออาการของโรคดีขึ้นแล้วจึงลดยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคออกทีละชนิด

๔) การรักษาแบบค่อยๆ ลดระหว่างรอยาสเตียรอยด์ออกฤทธิ์ คือ การใช้ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคหลายชนิดร่วมกับการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นระหว่างรอฤทธิ์ของยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค เมื่ออาการข้ออักเสบดีขึ้นจึงลดการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์

๕) การรักษาแบบจริงจังมุ่งสู่ระยะโรคสงบ คือ การรักษาที่จัดตามอาการของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีอาการของโรคน้อยที่สุด หรือเข้าสู่ระยะสงบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาของการประเมินเพื่อทำการปรับเปลี่ยนยา คือ ๑ - ๓ เดือน

๓. คอร์ติโคสเตียรอยด์

การใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันถึงผลดีและผลเสียของยา จากการศึกษาการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ กับไม่ใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์แล้วประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของกระดูกและข้อด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ เมื่อติดตามดูผู้ป่วยเป็นเวลา ๒ ปี ปรากฏว่าการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ได้ผลดีกว่า อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงของข้อที่แย่ลง และมีความพิการของข้อ ส่วนผลข้างเคียงของการใช้ยาในระยะยาว คือ กระดูกพรุน กระเพาะอาหารเป็นแผล การติดเชื้อ และผู้ป่วยมีอายุสั้นกว่าที่ควร

ข้อบ่งใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ ได้แก่

- หลอดเลือดอักเสบที่มีอาการแสดงของแผลที่ผิวหนัง
- พังผืดในปอดที่เป็นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
- หลอดเลือดหัวใจอักเสบ
- โรคที่มีอาการทั่วร่างกายและรุนแรง มีไข้

๔. การผ่าตัด

แม้ว่าการควบคุมการอักเสบของข้อสามารถทำได้โดยวิธีการรักษาดังกล่าวข้างต้น แต่ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เรื้อรังอาจมีอาการจากโครงสร้างข้อเสียหาย ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดเป็นการจำแนกการรักษาแบบที่ไม่ใช้ยา มีข้อบ่งชี้ดังนี้

๑) อาการปวดที่ทนไม่ได้ จากโครงสร้างของข้อที่เสียไป

๒) การทำงานของข้อเสียไป จากโครงสร้างของข้อที่เสียหาย ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเยื่อบุข้ออักเสบเรื้อรังทำลายโครงสร้างข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไทย ตำแหน่งที่พบปัญหาคือ ข้อเข่า

ผู้ป่วยมีการสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อจนกระดูกทั้งสองข้างเสียดสีกัน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อเข่า ข้อเข่าฝืด และมีมุมการเคลื่อนไหวลดลง การผ่าตัดในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ที่ทำบ่อยและประสบความสำเร็จ ได้แก่

- การผ่าตัดเพื่อลดการกดเบียดเส้นประสาท
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เมื่อโครงสร้างข้อเข่าเสียหายจนเป็นอุปสรรคต่อการเดิน
- การต่อเส้นเอ็นมือที่ขาด สำหรับผู้ป่วยที่เส้นเอ็นกระดกนิ้วมือขาด
- การตัดหัวกระดูกนิ้วเท้า เมื่อหัวกระดูกข้อโคนนิ้วเท้าเคลื่อนและไปกดฝ่าเท้า ทำให้มีอาการปวด หรือเกิดเป็นแผลที่ฝ่าเท้า

ผลของการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัด ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมารับการผ่าตัด อาการของผู้ป่วยต่อการรักษาทางยาก่อนการผ่าตัด การดูแลหลังการผ่าตัด การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัดและการบริหารข้อก็มีส่วนสำคัญมากในการทำให้การทำงานของข้อดีและคงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ การผ่าตัดไหล่ และการผ่าตัดมือ

๖. สรุป

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการให้การรักษาโดยทันทีเมื่อมีการวินิจฉัยโรคแล้ว เพื่อให้ข้ออักเสบเข้าสู่ระยะสงบ หรือหากยังคงเป็นอยู่แต่ก็ไม่มีการทำลายของข้อ หรือมีการทำลายแต่เพียงเล็กน้อย การรักษาตั้งแต่แรกเริ่มจะให้ผลในระยะยาวดีกว่าการรักษาช้า สิ่งที่ยังคงเป็นคำถามคือ ยาต้านรูมาทิซึมที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคชนิดใดที่ได้ผลดีที่สุดในการเริ่มรักษาผู้ป่วย ปัจจุบันมีการรักษาแบบใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดูแลข้ออักเสบให้สงบทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม และมีข้อที่สามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น ในทางตรงกันข้ามการรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ข้อถูกทำลาย ข้อพิการและการทำงานของข้อเสียไป ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้ กลายเป็นคนทุพพลภาพไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติหรือเกิดอาการปวดข้อ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อจะได้ให้การรักษาอย่างทันกาล

ดูเพิ่มเติมเรื่อง ผู้สูงอายุ เล่ม ๒๗

บรรณานุกรม

สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. **การดูแลโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์.** กรุงเทพฯ : ฮั่วน้ำพริ้นติ้ง, ๒๕๔๔.

Birrel FN, Isaacs JD. "Extraarticular manifestations of rheumatoid arthritis." In Koopman WJ, Moreland LW, eds. **Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn.** Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005: pp. 1195-1205.

Chatham WW, Blackburn WD. In Koopman WJ, Moreland LW, eds. **Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn.** Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005: pp. 1207-26.

Firestein GS. "Etiology and pathogenesis of rheumatoid arthritis." In Harris ED, Budd RC, Genovese MC, Firestein GS, Sargent JS, Sledge CB, eds. **Kelley's Textbook of Rheumatology, 7th edn.** Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005: pp. 996-1042.

Fox DA. **Etiology and pathogenesis of rheumatoid arthritis.** In Koopman WJ, Moreland LW, eds. Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins 2005: pp. 1089-115.

Genovese MC, Harris ED. "Treatment of rheumatoid arthritis." In Harris ED, Budd RC, Genovese MC, Firestein GS, Sargent JS, Sledge CB, eds. **Kelley's Textbook of Rheumatology, 7th edn.** Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005: pp. 1079-100.

Hale LP. "Pathology of rheumatoid arthritis and associated disorders." In Koopman WJ, Moreland LW, eds. **Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn.** Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005: pp. 1117-40.

Harris ED. "Clinical features of rheumatoid arthritis." In Harris ED, Budd RC, Genovese MC, Firestein GS, Sargent JS, Sledge CB, eds. **Kelley's Textbook of Rheumatology, 7th edn.** Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005: pp. 1043-78.

Jasin HE. "Mechanisms of tissue damage in rheumatoid arthritis." In Koopman WJ, Moreland LW, eds. **Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn.** Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005: pp. 1141-64.

O' Dell JR. "Rheumatoid arthritis : The clinical picture." In Koopman WJ, Moreland LW, eds. **Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn.** Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005: pp. 1165-94.

Oliver AM, St. Clair EW. "Rheumatoid arthritis : Treatment and assessment." In Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH, eds. **Primer on rheumatic diseases, 13th edn.** New York : Springer, 2008: pp. 133-141.

Tehlirian CV, Bathon JM. "Rheumatoid arthritis : Clinical and laboratory manifestations." In Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH, eds. **Primer on rheumatic diseases, 13th edn.** New York : Springer, 2008: pp. 114-21.

Waldenburger JM, Firestein GS. "Rheumatoid arthritis : Epidemiology, pathology, and pathogenesis." In Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH, eds. **Primer on rheumatic diseases, 13th edn.** New York : Springer, 2008: pp. 122-32.

Zvaifler NJ, Corr Maripat. "The evaluation and treatment of rheumatoid arthritis." In Koopman WJ, Moreland LW, eds. **Arthritis and allied conditions A textbook of Rheumatology, 15th edn.** Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005: pp. 1249-61.